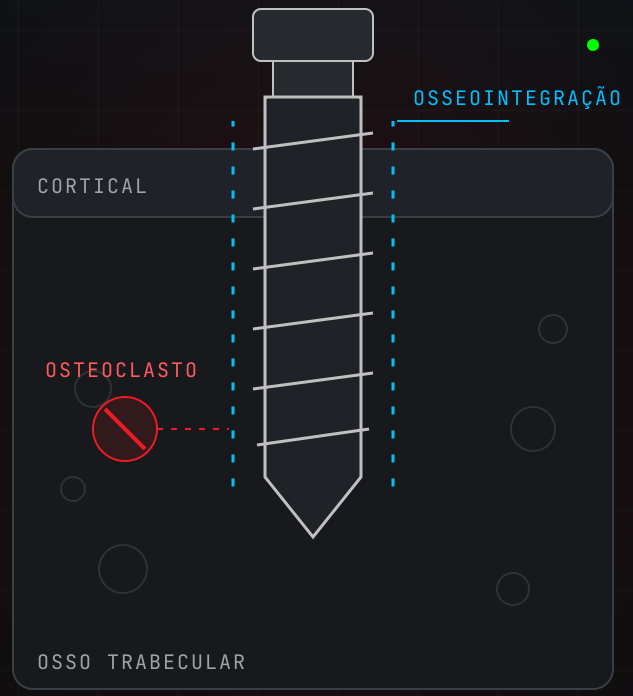
// TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O uso de bifosfonatos em implantodontia

Questão: quais cuidados considerar ao planejar implantes em pacientes que utilizam bifosfonatos?



Giovanna Borges de Oliveira Nery

Especialização em Implantodontia

Orientadora: **Profa. Dra. Carolina Ventura**

Bifosfonatos: preservam a massa óssea, mas exigem atenção na implantodontia

INDICAÇÕES > OSTEOPOROSE | DOENÇA DE PAGET | MIELOMA MÚLTIPLO | METÁSTASES ÓSSEAS

FÁRMACO
Bifosfonato

INIBE

ALVO
Osteoclastos
Células da reabsorção óssea

EFEITO
Preservação da massa óssea

[!] O sucesso dos implantes depende da **osseointegração** e de uma resposta óssea adequada, e há risco de **MRONJ**: osteonecrose dos maxilares relacionada a medicamentos.

Relevância

Envelhecimento da população e mais pacientes em tratamento com esses medicamentos.

Analisar benefícios, riscos e implicações clínicas dos bifosfonatos na implantodontia

01 Mecanismos de ação

02 Relação com a osseointegração

03 Resultados dos implantes

04 Cuidados no planejamento do tratamento

QUESTÃO CENTRAL

Quais cuidados devem ser considerados ao planejar implantes em pacientes que utilizam bifosfonatos?

[04] METODOLOGIA

Revisão narrativa da literatura, descritiva e qualitativa

BASES · ABR–JUN 2026

PubMed
SciELO
Google Acadêmico (complementar)

RECORTE

2021–2025

+ 1 referência anterior sobre suspensão temporária

MATRIZ DE SÍNTESE

08

publicações diretamente relacionadas à questão de pesquisa

termos > bifosfonatos · implantes dentários · osseointegração · falha de implantes · osteonecrose dos maxilares

[!] Revisão **narrativa**: não foi conduzida como revisão sistemática e não utilizou todas as etapas do protocolo **PRISMA**.

Ação do medicamento × metabolismo ósseo ao redor do implante

BENEFÍCIO

Redução da reabsorção óssea

Favorece o tratamento das doenças para as quais o fármaco é indicado.

×

PONTO DE ATENÇÃO

A remodelação óssea também atua no implante

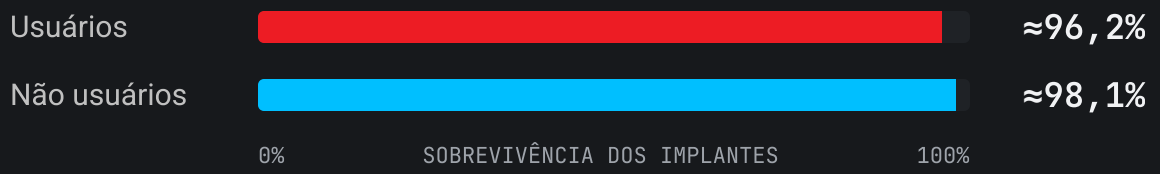
Participa da adaptação e da reparação do osso peri-implantar.

Preservar massa óssea, **isoladamente**, não significa resposta implantodôntica necessariamente melhor. O efeito deve ser avaliado **no contexto de cada paciente**.

Alta sobrevivência pode coexistir com possível aumento do risco de falha

Jung et al., 2025

Sem aumento estatisticamente significativo da falha de implantes.



Sulaiman et al., 2023 · 33 publicações

Maior chance de falha no nível do implante; sobrevivência absoluta ainda elevada.

Crupi et al.

Resultados favoráveis em pacientes selecionados, sobretudo com baixa dose para osteoporose.

[!] Divergência entre estudos: **populações, medicamentos, doses e acompanhamento** não foram iguais. Cautela na interpretação.

O risco não se define apenas pela via de administração

INDICAÇÃO TERAPÊUTICA · POTÊNCIA DO FÁRMACO · DOSE CUMULATIVA · DURAÇÃO DO TRATAMENTO · CONDIÇÕES SISTÊMICAS · SAÚDE BUCAL



Osteoporose
baixa dose

Oncológico
alta dose

Infecções locais e manipulação óssea são relevantes, mas o risco resulta da **interação entre fatores**.

MRONJ · CRITÉRIOS AAOMS

01 Uso atual ou anterior dos medicamentos relacionados

02 Osso exposto ou sondável por fístula por **mais de 8 semanas**

03 Ausência de radioterapia ou doença metastática evidente nos maxilares

Planejamento clínico em usuários de bifosfonatos

01
Anamnese
Qual medicamento, por qual motivo, em qual dose e há quanto tempo

02
Avaliação
Condições periodontais, infecções e fatores sistêmicos do reparo ósseo

03
Planejamento
Médico prescritor, riscos e incertezas ao paciente, controle clínico e radiográfico

04
Prevenção
Controle de infecções, higiene bucal e técnica cirúrgica cuidadosa

[!] **Nenhuma medida isolada** garante ausência de complicações, e um bom resultado inicial não elimina **alterações tardias**: o acompanhamento é essencial.

Drug holiday: sem evidência para recomendação universal

NA LITERATURA ANALISADA

Não há evidência suficiente para recomendar a suspensão de forma universal como prevenção da osteonecrose.

A DECISÃO PESA

- Benefícios do medicamento
- Riscos da doença de base: **fraturas** ou **progressão**

[!] Decisão **compartilhada com o médico prescritor**. O cirurgião-dentista **não deve suspender** a medicação por conta própria.

Bifosfonatos não são contraindicação absoluta para todos os pacientes

OSTEOPOROSE · BAIXA DOSE

Implantes podem ser considerados

Em pacientes selecionados, após avaliação individualizada e esclarecimento das incertezas.

ONCOLÓGICO · ALTA DOSE

Maior cautela

Indicação mais restritiva.

→ A decisão considera o **conjunto das condições do paciente**, não apenas a via de administração.

>> **Perspectiva:** estudos prospectivos que diferenciem medicamentos, doses e indicações, para esclarecer os riscos em longo prazo.

// OBRIGADA PELA ATENÇÃO

Perguntas?

Giovanna Borges de Oliveira Nery

Orientadora: Profa. Dra. Carolina Ventura · Especialização em Implantodontia